

POCKET CARDS — CLÍNICA MÉDICA & UTI

Santa Casa de Misericórdia de Sobral | Dr. Aldenir Rocha — CRM-CE 16587 | 9 Protocolos | 2026

■ Cartões de referência rápida para uso beira do leito. Para detalhes completos, consultar os protocolos expandidos. Indicado para internos, residentes e plantonistas.

ÍNDICE DE CARTÕES

#	Cartão	Conteúdo Resumido
1	Sepse / Bundle 1h	qSOFA, bundle, ATB por foco, vasopressores
2	Controle Glicêmico	Metas, escala insulina, hipoglicemia, CAD quick
3	Alta Segura	Critérios, reconciliação, sinais de alarme
4	Tromboprofilaxia	Padua, Enoxaparina, HAS-BLED, CHA ₂ DS ₂ -VASc
5	Evolução SOAP	Estrutura S-O-A-P rápida de referência
6	PCR / ACLS	Algoritmo FV/AESP, drogas, Hs e Ts
7	Dor Torácica	ECG diagnóstico, Wells, troponina, dissecção
8	Hiponatremia	SIADH, correção segura, SDO
9	IC Aguda	Perfis, diurético, VNI, inotrópicos

■ SEPSE — POCKET CARD Bundle 1ª Hora • SSC 2021	■ GLICEMIA — POCKET CARD Metas • Insulina • CAD • ADA 2024																
DEFINIÇÕES - SIRS: ≥ 2: Temp$>38/ <36$, FC>90, FR>20, Leuco$>12k/ <4k$ - SEPSE = SIRS + disfunção orgânica (SOFA ≥ 2) - CHOQUE SÉPTICO = Sepse + vasopressor + Lactato > 2	META GLICÊMICA HOSPITALAR - UTI / Enfermaria: 140–180 mg/dL - Evitar hipoglicemia: < 70 = tratar imediatamente - NICE-SUGAR: controle estrito (<110) $\uparrow$ mortalidade																
qSOFA (≥ 2 = alto risco) - FR ≥ 22 irpm (1pt) - Glasgow < 15 (1pt) - PAS ≤ 100 mmHg (1pt)	ESCALA CORRETIVA (PADRÃO) <table><tr><th>Glicemia</th><th>Insulina Regular SC</th></tr><tr><td>< 70</td><td>TRATAR HIPOGLICEMIA</td></tr><tr><td>70–180</td><td>Sem insulina</td></tr><tr><td>181–220</td><td>2 U SC</td></tr><tr><td>221–260</td><td>4 U SC</td></tr><tr><td>261–300</td><td>6 U SC</td></tr><tr><td>301–400</td><td>8–10 U SC</td></tr><tr><td>> 400</td><td>Chamar médico</td></tr></table>	Glicemia	Insulina Regular SC	< 70	TRATAR HIPOGLICEMIA	70–180	Sem insulina	181–220	2 U SC	221–260	4 U SC	261–300	6 U SC	301–400	8–10 U SC	> 400	Chamar médico
Glicemia	Insulina Regular SC																
< 70	TRATAR HIPOGLICEMIA																
70–180	Sem insulina																
181–220	2 U SC																
221–260	4 U SC																
261–300	6 U SC																
301–400	8–10 U SC																
> 400	Chamar médico																
BUNDLE DA 1ª HORA ① Colher LACTATO sérico ② HEMOCULTURAS x2 pares ③ ATB amplo espectro $\leq 1h$ (choque) / $\leq 3h$ (sepse) ④ SF 0,9% 30 mL/kg se hipot. ou Lactato ≥ 4 ⑤ Vasopressor (Noradrenalina) se PAM < 65	HIPOGLICEMIA — REGRA DOS 15 - Consciente: 15g CHO (3 saches açúcar + 150mL água) - Sem VO: Glicose 50% 40mL EV ou Glucagon 1mg IM/SC - Repetir em 15 min se ainda < 70 mg/dL																
ATB EMPÍRICO RÁPIDO <table><tr><th>Foco</th><th>ATB</th></tr><tr><td>Pulmonar</td><td>Amp/Sul + Azitro OU Pip/Tazo (PAH)</td></tr><tr><td>Abdominal</td><td>Pip/Tazo OU Cefot+Metro</td></tr><tr><td>Urinário</td><td>Ceftriaxona 2g OU Cefepima(ESBL)</td></tr><tr><td>Desconhecido</td><td>Pip/Tazo + Vancomicina</td></tr></table>	Foco	ATB	Pulmonar	Amp/Sul + Azitro OU Pip/Tazo (PAH)	Abdominal	Pip/Tazo OU Cefot+Metro	Urinário	Ceftriaxona 2g OU Cefepima(ESBL)	Desconhecido	Pip/Tazo + Vancomicina	CAD — CHECKLIST RÁPIDO - K^{+} $< 3,5 \rightarrow$ repor ANTES de insulina! - Hidratação: SF 0,9% 1L/h na 1ª hora - Insulina: Regular EV 0,1 U/kg/h - Fechar CAD: pH $\geq 7,30$ + HCO$3 \geq 15$ + GA < 12 - Transição SC: basal 1–2h antes de suspender EV						
Foco	ATB																
Pulmonar	Amp/Sul + Azitro OU Pip/Tazo (PAH)																
Abdominal	Pip/Tazo OU Cefot+Metro																
Urinário	Ceftriaxona 2g OU Cefepima(ESBL)																
Desconhecido	Pip/Tazo + Vancomicina																
■ NORADRENALINA 1ª escolha. Corticoide se Nora $\geq 0,25$ mcg/kg/min por $\geq 4h$																	

■ ALTA SEGURA — POCKET CARD

Critérios • Reconciliação • Sinais de Alarme

CRITÉRIOS MÉDICOS DE ALTA

- ✓ Hemodinamicamente estável sem vasopressor ≥24h
- ✓ SpO₂ ≥ 92% (ar ambiente ou O₂ domiciliar)
- ✓ Afebril ≥ 24h OU febre em controle com ATB oral
- ✓ Tolerando dieta oral OU enteral domiciliar
- ✓ Diagnóstico estabelecido + tratamento oral definido
- ✓ Cuidador identificado + retorno agendado

RECONCILIAÇÃO MEDICAMENTOSA

- Comparar medicamentos da internação vs. pré-internação
- Identificar o que mudou, suspendeu ou foi adicionado
- Receituário legível: nome genérico + dose + freq + duração
- Atenção: anticoagulantes, insulina, digitálicos, imunossup.

SINAIS DE ALARME — RETORNO URGENTE

- Falta de ar súbita / dor no peito
- Confusão mental / fraqueza súbita / convulsão
- Febre > 38,5°C + piora do estado geral
- Glicemia < 60 (tontura, tremor) ou > 300 (sede + poliúria)
- Sangramento em anticoagulado que não cessa

■ RETORNO em ≤ 7 dias após alta hospitalar por IC ou sepse

■ TROMBOPROFILAXIA — POCKET CARD

Padua • Enoxaparina • HAS-BLED • CHA₂DS₂-VASc

ESCORE DE PADUA

Fator	Pts
Câncer ativo	3
TVP/TEP prévio	3
Imobilidade ≥3d	3
Trombofilia	3
Cirurgia recente ≤1 mês	2
Idade ≥70	1
IC/IR	1
IAM/AVC	1
Infecção aguda	1
Obesidade IMC≥30	1

- Padua ≥ 4: ENOXAPARINA 40 mg SC 1x/dia
- CICr 15–30: HNF 5.000 UI SC 8/8h
- TIH (queda ≥50% plaquetas em 5–14d): SUSPENDER toda heparina → Fondaparinux

CHA₂DS₂-VASc (FA) → anticoagular se ≥2 homem / ≥3 mulher

Letra	Fator	Pts
C	IC/FEVE<40%	1
H	HAS	1
A ₂	≥75 anos	2
D	DM	1
S ₂	AVC/AIT prévio	2
V	Doença vasc.	1
A	65–74 anos	1
Sc	Sexo fem.	1

DOAC NA FA (1ª escolha em FA não valvar)

- Apixabana 5 mg 12/12h (2,5mg se ≥2: >80a, <60kg, Cr>1,5)
- Rivaroxabana 20 mg 1x/dia com jantar
- Warfarina: prótese valvar mecânica, estenose mitral, CICr<15

■ EVOLUÇÃO SOAP — POCKET CARD

Estrutura Diária • Enfermaria Clínica Médica

S — SUBJETIVO

- Queixas do paciente: melhora/piora de sintomas
- Dor (escala 0–10), apetite, sono, humor
- Novos sintomas desde a última evolução

O — OBJETIVO

- SSVV: PA / FC / FR / Temp / SpO₂ / Glicemia
- Peso, diurese 24h, balanço hídrico
- Exame físico dirigido ao diagnóstico
- Resultados de exames (labs, imagem, culturas)

A — AVALIAÇÃO

- Diagnóstico principal atual + secundários ativos
- Resposta ao tratamento: melhorou / piorou / estável
- Problemas novos identificados

P — PLANO

- Exames solicitados hoje
- Medicações novas ou modificadas
- Interconsultas acionadas
- Meta do dia: _____
- Previsão de alta: ____/____/____ (critério: _____)

■ Assinar com nome legível + CRM + data + hora

■ PCR / ACLS — POCKET CARD

AHA 2020/2023 • RCP Alta Qualidade • Drogas

RCP ALTA QUALIDADE

- Freq: 100–120/min | Prof: 5–6 cm | Retorno completo
- Pausas ≤ 10s | Relação 30:2 (sem VA avançada)
- Rodiziar compressor a cada 2 min

FV/TVSP — DESFIBRILÁVEL

- RCP 2min → Choque 200J (bifásico) → RCP imediata
- Adrenalina 1mg EV no 2º ciclo, repetir 3–5min
- Amiodarona 300mg EV após 3º choque sem sucesso

AESP/ASSISTOLIA — NÃO DESFIBRILÁVEL

- RCP contínua + Adrenalina 1mg imediato
- Repetir adrenalina 3–5 min
- INVESTIGAR Hs e Ts!

Hs e Ts

H/T	Causa	Tratamento
H1	Hipovolemia	SF 1–2L rápido
H2	Hipoxia	Ventilar O ₂ 100%
H3	H+ Acidose	HCO ₃ 1mEq/kg
H4	Hipo/HiperK	CaGluconato EV
T1	Pneumotórax	Toracocentese 2ºEIC
T2	Tamponamento	Pericardiocentese
T3	TEP/IAM	Trombolítico/Cath
T4	Tóxico	Antídoto específico

■ Pós-PCR: SpO₂ 94–98% | PAM ≥ 65 | Gli 140–180 | Sem febre | ECG | UTI

■ DOR TORÁCICA — POCKET CARD			■ HIPONATREMIA — POCKET CARD		
IAM • TEP • Dissecção • AHA/ESC 2023			SIADH • Correção Segura • SDO • ESE 2022		
ECG < 10 MINUTOS — OBRIGATÓRIO			DIAGNÓSTICO RÁPIDO		
Padrão ECG	Diagnóstico	Condição	Parâmetro	SIADH	Hipovolêmica
Supra ST ≥1mm ≥2 deriv.	IAMCSST	REPERFUSÃO <90min!	Estado volêmico	Euvolêmico	Hipovolêmico
Infra ST / inv. T	IAMSSST/AI	Anticoag + antiplag	Sódio urinário	> 40 mEq/L	< 20 mEq/L
S1Q3T3 + taquic.	TEP	Wells + Ang	Osm. urinária	> 100 mOsm/kg	Variável
ECG normal	NÃO exclui IAM!	TnAS 0h/1h obrig.	Causa comum	SSRI, infecção, ca.	Vômito, diarreia, diurético
WELLS PARA TEP			VELOCIDADE DE CORREÇÃO		
Critério	Pts		• ■ MÁXIMO: 10 mEq/L em 24h (crônica: 8 mEq/L)		
Sinais TVP	3		• ■ MÁXIMO: 18 mEq/L em 48h		
TEP mais provável	3		• Correção rápida → SÍNDROME DE DESMIELINIZAÇÃO OSMÓTICA		
FC>100	1,5		EMERGÊNCIA NEUROLÓGICA (convulsão/coma)		
Imob/cirurg. recente	1,5		• SF 3%: 100 mL EV em 10–20 min (pode repetir 1–2x)		
TEP/TVP prévio	1,5		• Meta: elevar 5 mEq/L em 1h para romper edema cerebral		
Hemoptise	1		• Preparar SF 3%: 30mL NaCl20% + 70mL AD = 100mL		
Câncer	1		TRATAMENTO SIADH		
• Wells ≤4: D-dímero (negativo exclui)			• ① Tratar causa base (suspender SSRI, tratar infecção)		
• Wells >4: AngioTC imediata + heparina empírica			• ② Restrição hídrica 800 mL/dia		
SINAIS DE DISSECÇÃO AÓRTICA			• ③ Ureia oral 15–30 g/dia (econômica, eficaz)		
• Dor LANCINANTE máxima no início + irrad. costas			• ④ Tolvaptana 15 mg/dia (custo alto)		
• ΔPA entre braços ≥ 20 mmHg			■ Correção excessiva detectada: SG5% 3–5 mL/kg/h + Desmopressina 2mcg EV para FREAR		
• ECG sem supra → contraindica anticoagulação!					
• AngioTC urgente → Tipo A: cirurgia emergência					
■ IAM de VD: supra II/III/aVF + hipotensão → CONTRAINDICAR NITRATO					

■ IC AGUDA — POCKET CARD				■ NEWS2 — POCKET CARD				
Perfis • Diurético • VNI • ESC 2021				Early Warning Score • RCP 2017 • Deterioração Clínica				
PERFIS HEMODINÂMICOS				ESCORE NEWS2 — PARÂMETROS				
Perfil	Congst	Perfus	Cc	Parâmetro	0 pt	1 pt	2 pt	3 pt
A — Quente/Seco	Não	Boa	Otimizar; sem urgência	FR (lpm)	12–20	9–11 21–24	—	≤8 / ≥25
B — Quente/Úmido	Sim	Boa	DIURÉTICO EV + Vasodilatador	SpO2 (%)	≥96	94–95	92–93	≤91
C — Frio/Úmido	Sim	Baixa	INOTRÓPICO + O2 supl	O2 supl	Não	Sim	—	—
L — Frio/Seco	Não	Baixa	Desafio hídrico 250mL cauteloso	PA sist.	111–219	101–110 220+	91–100	≤90
DIURÉTICO PROTOCOLO				FC	51–90	41–50 91–110	111–130	≤40 / ≥131
- Naïve: Furosemida 20–40 mg EV bolus - Uso crônico VO: EV = dose oral habitual (1:1) - Resistência: + Hidroclorotiazida 25mg VO (bloq. seq.) - Meta diurese: >0,5 mL/kg/h Perda: 0,5–1 kg/dia				Consci.	Alerta	—	—	CVFU
				Temp(°C)	36,1–38	35,1–36 38,1–39	≤35/≥39,1	—
VNI (CPAP ou BiPAP)				INTERPRETAÇÃO NEWS2				
- Indicar se SpO2 < 90% após O2 suplementar - CPAP: EAP sem hipercapnia — PEEP 5–10 cmH2O - BiPAP: IC + DPOC (hipercapnia) — IPAP 12/EPAP 5 - IOT se: falha VNI, Glasgow < 8, vômito, PCR				Score	Risco	Ação		
				0	Baixíssimo	Monitorar rotina 12h		
				1–4	Baixo	Monitorar 4–6h		
				5–6 ou 3 num param.	Médio	Avaliar médico + 1h		
INOTRÓPICOS (perfil C/L)				≥7	ALTO	Médico sênior + 30min. Avaliar UTI		
- Dobutamina 2–20 mcg/kg/min (1ª escolha) - Milrinona 0,375–0,75 mcg/kg/min (beta-bloq. em uso) - Noradrenalina se choque (PAM < 65 + hipoperfusão)				SBAR — COMUNICAÇÃO SBAR				
				- S (Situação): "Paciente X, leito Y, deteriorou" - B (Background): "Internado por... diagnóstico..." - A (Avaliação): "PA, FC, FR, SpO2, NEWS2=..." - R (Recomendação): "Precisamos de avaliação urgente"				
■ NITRATO contraindicado: PAS<90, IAM de VD, uso de PDE-5 inib.				■ NEWS2 ≥ 7 = acionar médico imediatamente + avaliar transferência UTI				